

الناصور نفق غير طبيعي صغير يربط عضوين لا ينبغي أن يتصلا. في الحوض قد يتشكّل بين المثانة (أو الحالب أو الإحليل) والمهبل — مسببًا تسرّبًا مستمرًا للبول — أو بين المستقيم والمهبل — مما يسمح بمرور الغاز أو البراز عبر المهبل. لا تلتئم الناصورات عادةً من تلقاء نفسها، لكن يمكن إصلاحها.

عن هذه الحالة

- الناصور البولي التناسلي (مثل المثاني المهبلي) — تسرّب بول مستمر غير مسيطر عليه من المهبل ليلاً ونهارًا.
 - الناصور المستقيمي المهبلي — خروج غاز أو براز عبر المهبل، وعدوى متكررة، وتهيج.
- قد تكون الأعراض مزعجة ومُعزلة — لكنها مشكلة ميكانيكية لها حلّ ميكانيكي، وليست انعكاسًا لأي خطأ ارتكبيته.

الأسباب

- جراحة الحوض أو النسائية (كاستئصال الرحم) — السبب الأكثر شيوعًا في كثير من البلدان
- الولادة — خاصةً المخاض المطوّل أو المتعسّر (سبب رئيسي في جميع أنحاء العالم)
- الإشعاع، أو مرض التهاب الأمعاء، أو العدوى، أو (نادرًا) السرطان

تعلم المصطلحات

الناصور

نفق غير طبيعي يربط بين عضوين.

المثاني المهبلي

ناصور بين المثانة والمهبل.

المستقيمي المهبلي

ناصور بين المستقيم والمهبل.

اختبار الصيغة

حقن سائل ملوّن في المثانة أو المستقيم لتحديد موضع التسرّب.

تنظير المثانة

فحص بكاميرا داخل المثانة للكشف عن الفتحة.

رفرف Martius

رفرف نسيجي لتعزيز الإصلاح.

التحويل

توجيه مؤقت للبول أو البراز أثناء الشفاء.

هل يمكن علاجه؟ نعم — يمكن إصلاح معظم الناسورات، ويشفى كثيرون شفاءً تاماً. أحياناً يُغلق الناسور الصغير الحديث من تلقاء نفسه بالقسطرة، لكن معظمها يحتاج إلى جراحة مُخططة. التوقيت مهم: كثيراً ما ينتظر الجراح حتى تهدأ الالتهابات لتحسّن فرص نجاح الإصلاح.

كيف تُشخّص

- فحص سريري، غالباً مع اختبار الصبغة لتحديد موضع التسرّب
- تنظير المثانة وتصوير لتحديد الحجم والموقع والسبب
- البحث عن سبب مساهم (آثار الإشعاع، العدوى، التهاب الأمعاء)

كيف تُعالج

- 1 **العلاج المحافظ** — قد يُغلق الناسور البولي الصغير الحديث بترك القسطرة لعدة أسابيع.
- 2 **الإصلاح الجراحي** — إغلاق النفق عبر نهج مهبلي أو بطني، غالباً على طبقات.
- 3 **الرفرف النسيجي** — قد يُستخدم نسيج سليم (كرفرف Martius) لتعزيز الإصلاح، خاصةً بعد الإشعاع.
- 4 **التحويل المؤقت** — في بعض الناسورات المستقيمية المهبلية، يُحوّل مجرى البراز مؤقتاً لإتاحة الشفاء.

معلومات مفيدة

- احمي الجلد واستخدمي الفوط الصحية ريثما يُجرى الإصلاح؛ فريقك يساعدك على الراحة.
- إصلاح الناسورات بعد الإشعاع أكثر تعقيداً وعادةً يستلزم رفرقاً نسيجياً.
- قد تحتاجين إلى قسطرة واختبار شفاء قبل إزالتها.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة، أو تفاقم ألم الحوض
- علامات عدوى، أو نزيف غزير
- بعد الإصلاح: توقّف القسطرة عن التصريف، أو عودة التسرّب

ثلاثة أمور تُذكرها

1. الناسور اتصال غير طبيعي يسبّب تسرّب البول (بولي تناسلي) أو خروج الغاز والبراز عبر المهبل (مستقيمي مهبلي).
2. معظمها قابل للإصلاح — بعضها يُغلق بالقسطرة، لكن أغلبها يحتاج جراحة مُخططة وأحياناً رفرقاً نسيجياً.
3. التوقيت مهم؛ قد ينتظر فريقك هدوء الالتهاب. أبلغني عن أي حمّى أو علامات عدوى أو عودة للتسرّب بعد الإصلاح.